



en

PATIENT INFORMATION LEAFLET

Device Type: Intraocular Lens (Aphakic)

Introduction

Cataract is a condition that becomes more common as we age. A cataract forms over time as the eye's natural lens stiffens and gradually becomes opaque. People with cataracts experience 'cloudy vision'. Color become less vivid over time, and there is often increased sensitivity to light. For example, someone with cataract will likely experience an increased amount of glare from oncoming car headlights at night. Without treatment, cataract will eventually block light passing through the eye and cause blindness.

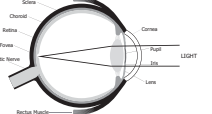


Fig. 1: The anatomy of the eye

How does cataract impact your vision?

A cataract affects the eye's natural lens, which is called the crystalline lens. Normally, this lens helps focus light onto the back of the eye (the retina) so we can see clearly. The lens is flexible and changes shape to help us focus on things both near and far. When we look at something close, the lens curves; when we look at something far away, it flattens. This ability of the lens to adjust for different distances is called "accommodation."

As we get older, the lens becomes less flexible, making it harder to focus on close objects—a condition called presbyopia, which can make reading small print difficult. A cataract adds another problem: the lens, which is normally clear, gradually becomes cloudy. This makes vision blurry over time. When cataracts start to affect vision, the cloudy natural lens needs to be removed and replaced with an artificial lens through surgery.

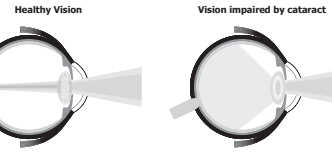


Fig. 2: Vision simulation without and with cataract

What is an Intraocular Lens (IOL)?

Intraocular lenses are artificial lenses used in modern cataract surgery. They are implanted in the capsular bag to replace the human crystalline lens, which is clouded by the cataract. Intraocular lenses are indicated for adult patients 18 years of age and above with cataract.

There has been significant advancement in materials and designs for intraocular lenses. We offer Intraocular lenses of different material types which includes: polymethyl methacrylate (PMMA), acrylic materials such as hydrophobic (repelling water) acrylic and hydrophilic (absorbing water) acrylic.



Fig. 3: Representative image of an Artificial Intraocular Lens

Different types and performance of the IOL

There are different types of lenses currently available. Your eye doctor will discuss which type of lens is best for you. Treatment options other than new permanent lens include glasses with thick lenses and contact lenses. Discuss potential risks and benefits of your treatment options with your eye doctor.

- **Monofocal IOLs**
Monofocal IOLs restore clear distance vision. This means that you should see well when you go to a ball game or read distant signs. You will probably need glasses for near vision tasks such as reading a book, writing, or doing crafts. You may also need glasses for intermediate vision activities such as working on a computer, putting on make-up, or shaving.
- **Multifocal IOLs**
All IOLs generally are designed for distance vision. However, multifocal IOLs are also designed to improve near and intermediate vision compared to a monofocal lens. This means that you should see well whether you go to a ball game or read a book. Multifocal lenses have different powers for near vision, based on your lifestyle needs. Overall, you may wear glasses less often for daily tasks. However, the sharpness of your vision may also decrease compared to a monofocal lens. This is especially the case under poor visibility conditions such as dim light or fog. You may also notice more halos (rings around light) or glare (reflected light, making it difficult to see). Both are common with multifocal IOLs.
- **EDoF (Extended Depth of Focus) IOLs**
It enables sharp vision ranging from far to intermediate distances, such as a computer monitor. For close-up activities such as reading fine print and precision work, patients implanted with EDoF lenses may need to wear reading glasses. However, they will experience fewer visual disturbances at night, which are sometimes caused by bright light sources with multifocal IOLs. EDoF lenses thus present an attractive combination of more spectacle independence than monofocal IOLs and fewer potential side effects than multifocal IOLs.
- **Toric IOLs**
Toric IOLs restore clear distance vision for patients with astigmatism. Astigmatism is blurred or distorted vision caused by an irregularly shaped cornea. If you have astigmatism, a Toric IOL may be the right choice for you.
- **Multifocal Toric IOLs**
Multifocal toric intraocular lenses are designed to correct astigmatism while also improving vision at multiple distances, including far, intermediate, and near. This may allow you to perform many daily activities, such as reading, using a computer, or seeing distant objects, with reduced dependence on glasses.

What to expect before cataract surgery

You will be evaluated before surgery. This includes checking for any eye diseases and measuring your eye for the correct lens power. If you wear contact lenses, your eye doctor may ask you to stop wearing them before being tested. Tell your eye doctor if you have any health conditions that may affect your surgery or vision. Examples include high blood pressure, diabetes, and heart disease. Give your eye doctor a current list of your medications. Plan to have someone else drive you home after surgery.

what to expect during cataract surgery

Cataract surgery is typically performed as an outpatient procedure. You will be given anesthesia in the form of eye drops to numb your eye. Typically, you will be fully awake during the surgery. Expect to feel little or no discomfort. Your eye doctor will use a microscope to have a magnified view of your eye. Your natural lens sits in a bag-like structure called the lens capsule. The lens capsule is located just behind the colored part of your eye (iris). A small incision is made in the outer surface of the eye. The eye doctor inserts a tiny probe through this opening to break up the cataract lens. Your eye doctor then uses a small vacuum-like device to remove the cataract pieces from your eye. Now there will be space for the IOL to be placed in your eye, to replace natural lens that your eye doctor has just removed. Your doctor will insert the IOL through the same tiny incision. When the surgery is complete, your eye doctor may place a protective patch or shield over your eye.



fr

NOTICE D'INFORMATION DESTINÉE AU PATIENT

Type de dispositif : Lentille intraoculaire (aphaque)

Introduction

La cataracte est une affection qui devient plus fréquente avec l'âge. Une cataracte se développe au fil du temps lorsque le cristallin naturel de l'œil se rigidifie et devient progressivement opaque. Les personnes atteintes de cataracte présentent une vision « trouble ». Les couleurs deviennent moins vives avec le temps et une sensibilité accrue à la lumière est souvent observée. Par exemple, une personne atteinte de cataracte ressentira probablement un éblouissement plus important causé par les phares des véhicules venant en sens inverse la nuit. Sans traitement, la cataracte finira par bloquer le passage de la lumière à travers l'œil et entraînera la cécité.

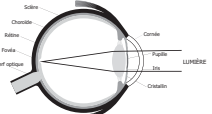


Fig. 1 : Anatomie de l'œil

Comment la cataracte affecte-t-elle votre vision ?

La cataracte affecte le cristallin naturel de l'œil, appelé cristallin. Normalement, ce cristallin aide à focaliser la lumière sur le fond de l'œil (la rétine) afin que nous puissions voir clairement. Le cristallin est souple et change de forme pour nous aider à faire la mise au point sur des objets proches comme éloignés. Lorsque nous regardons un objet proche, le cristallin se courbe ; lorsque nous regardons un objet éloigné, il s'aplatit. Cette capacité du cristallin à s'adapter à différentes distances est appelée « accommodation ».

Avec l'âge, le cristallin devient moins souple, ce qui rend plus difficile la mise au point sur les objets proches — une affection appelée presbytie, qui peut rendre la lecture des petits caractères difficile. La cataracte ajoute un autre problème : le cristallin, normalement transparent, devient progressivement trouble. Cela entraîne une vision floue au fil du temps. Lorsque la cataracte commence à affecter la vision, le cristallin naturel opacifié doit être retiré et remplacé par une lentille artificielle au moyen d'une intervention chirurgicale.

Vision normale

Vision altérée par la cataracte

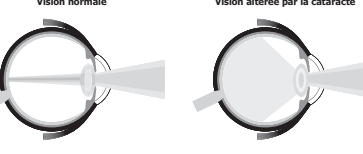


Fig. 2 : Simulation de la vision sans et avec cataracte

Qu'est-ce qu'une lentille intraoculaire (LIO) ?

Les lentilles intraoculaires sont des lentilles artificielles utilisées dans la chirurgie moderne de la cataracte. Elles sont implantées dans le sac capsulaire pour remplacer le cristallin humain devenu opaque à cause de la cataracte. Les lentilles intraoculaires sont indiquées chez les patients adultes âgés de 18 ans et plus atteints de cataracte.

Les matériaux et les conceptions des lentilles intraoculaires ont connu des avancées considérables. Nous proposons des lentilles intraoculaires fabriquées à partir de différents types de matériaux, notamment le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ainsi que des matériaux acryliques tels que l'acrylique hydrophobe (repoussant l'eau) et l'acrylique hydrophile (absorbant l'eau).



Fig. 3 : Image représentative d'une lentille intraoculaire artificielle

Différents types de LIO et leurs performances

Il existe actuellement différents types de lentilles disponibles. Votre ophtalmologiste discutera avec vous du type de lentille le mieux adapté à votre situation. Les autres options de traitement qu'une nouvelle lentille permanente comprennent les lunettes à verres épais et les lentilles de contact. Discutez des risques et des avantages potentiels de vos options de traitement avec votre ophtalmologiste.

- **LIO monofocales**
Les LIO monofocales restaurent une vision nette de loin. Cela signifie que vous devriez bien voir lorsque vous assistez à un événement sportif ou lorsque vous lisez des panneaux éloignés. Vous aurez probablement besoin de lunettes pour les activités de vision de près telles que la lecture, l'écriture ou les loisirs créatifs. Vous pourriez également avoir besoin de lunettes pour les activités de vision intermédiaire, comme travailler sur un ordinateur, vous maquiller ou vous raser.
- **LIO multifocales**
Toutes les LIO sont généralement conçues pour la vision de loin. Cependant, les LIO multifocales sont également conçues pour améliorer la vision de près et intermédiaire par rapport à une lentille monofocale. Cela signifie que vous devriez bien voir aussi bien lorsque vous assistez à un événement sportif que lorsque vous lisez un livre. Les lentilles multifocales offrent différentes puissances pour la vision de près, en fonction de votre mode de vie et de vos besoins. Globalement, vous pourriez porter des lunettes moins souvent pour les tâches quotidiennes. Cependant, la netteté de votre vision peut être réduite par rapport à celle obtenue avec une lentille monofocale. Cela est particulièrement vrai dans des conditions de visibilité réduite, comme une faible luminosité ou le brouillard. Vous pouvez également remarquer davantage de halos (anneaux autour des sources lumineuses) ou d'éblouissements (lumière réfléchie rendant la vision plus difficile). Ces phénomènes sont fréquents avec les LIO multifocales.
- **LIO EDoF (profondeur de champ étendue)**
Les LIO à profondeur de champ étendue permettent une vision nette allant de loin jusqu'aux distances intermédiaires, comme la visualisation d'un écran d'ordinateur. Pour les activités de près telles que la lecture de petits caractères ou les travaux de précision, les patients porteurs de lentilles EDoF peuvent avoir besoin de porter des lunettes de lecture. Toutefois, ils ressentiront moins de perturbations visuelles nocturnes, parfois provoquées par les sources lumineuses intenses chez les porteurs de LIO multifocales. Les lentilles EDoF représentent ainsi une combinaison intéressante offrant une plus grande indépendance vis-à-vis des lunettes que les LIO monofocales, tout en présentant moins d'effets secondaires potentiels que les LIO multifocales.
- **LIO toriques**
Les LIO toriques restaurent une vision nette de loin chez les patients présentant un astigmatisme. L'astigmatisme correspond à une vision floue ou déformée causée par une cornée de forme irrégulière. Si vous souffrez d'astigmatisme, une LIO torique peut constituer le bon choix pour vous.
- **LIO multifocales toriques**
Les lentilles intraoculaires multifocales toriques sont conçues pour corriger l'astigmatisme tout en améliorant la vision à plusieurs distances, notamment de loin, à distance intermédiaire et de près. Elles peuvent vous permettre d'effectuer de nombreuses activités quotidiennes, telles que la lecture, l'utilisation d'un ordinateur ou l'observation d'objets éloignés, avec une dépendance réduite aux lunettes.

À quoi s'attendre avant une chirurgie de la cataracte

Vous serez examiné avant l'intervention chirurgicale. Cet examen comprend la recherche d'éventuelles maladies oculaires et la mesure de votre œil afin de déterminer la puissance correcte de la lentille à implanter. Si vous portez des lentilles de contact, votre ophtalmologiste pourra vous demander d'arrêter de les porter avant les examens. Informez votre ophtalmologiste de tout problème de santé susceptible d'influencer votre intervention ou votre vision. Parmi les exemples figurent l'hypertension artérielle, le diabète et les maladies cardiaques. Fournissez à votre ophtalmologiste une liste à jour de tous les médicaments que vous prenez. Prévoyez qu'une autre personne vous accompagne à votre domicile après l'intervention chirurgicale.



de

PATIENTENINFORMATIONSBLA TT

Produkttyp: Intraokularlinse (aphak)

Einleitung

Der Graue Star (Katarakt) ist eine Erkrankung, die mit zunehmendem Alter häufiger auftritt. Ein Katarakt entwickelt sich im Laufe der Zeit, wenn die natürliche Linse des Auges steifer wird und allmählich eintrübt. Menschen mit Katarakt erleben eine „verschommene“ Sicht. Farben wirken mit der Zeit weniger lebendig, und häufig besteht eine erhöhte Lichtempfindlichkeit. Beispielsweise wird eine Person mit Katarakt nachts wahrscheinlich stärker durch die Scheinwerfer entgegenkommender Fahrzeuge geblendet. Unbehandelt blockiert der Katarakt schließlich den Lichteinfall ins Auge und kann zur Erblindung führen.

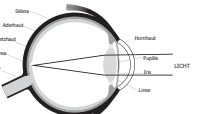


Abb. 1: Anatomie des Auges

Wie beeinflusst ein Katarakt Ihr Sehvermögen?

Ein Katarakt betrifft die natürliche Linse des Auges, die als Augenlinse (Kristalllinse) bezeichnet wird. Normalerweise hilft diese Linse dabei, das Licht auf den hinteren Teil des Auges (die Netzhaut) zu fokussieren, sodass wir klar sehen können. Die Linse ist flexibel und verändert ihre Form, um sowohl nahe als auch entfernte Objekte scharfzustellen. Wenn wir etwas in der Nähe betrachten, wölbt sich die Linse; wenn wir etwas in der Ferne betrachten, flacht sie sich ab. Diese Fähigkeit der Linse, sich an unterschiedliche Entfernungen anzupassen, wird als „Akkommodation“ bezeichnet.

Mit zunehmendem Alter wird die Linse weniger flexibel, wodurch das Fokussieren naher Objekte schwieriger wird – ein Zustand, der als Presbyopie (Altersichtigkeit) bezeichnet wird und das Lesen kleiner Schrift erschweren kann. Ein Katarakt bringt ein weiteres Problem mit sich: Die normalerweise klare Linse wird allmählich trüb. Dadurch wird das Sehvermögen mit der Zeit unscharf. Wenn der Katarakt das Sehvermögen beeinträchtigt, muss die eingetrübte natürliche Linse operativ entfernt und durch eine künstliche Linse ersetzt werden.

Gesundes Sehvermögen

Durch Katarakt beeinträchtigtes Sehvermögen

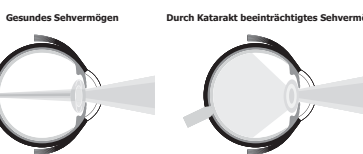


Abb. 2: Simulation des Sehens ohne und mit Katarakt

Was ist eine Intraokularlinse (IOL)?

Die Intraokularlinsen sind künstliche Linsen, die in der modernen Kataraktchirurgie verwendet werden. Sie werden in den Kapselsack implantiert, um die menschliche Augenlinse zu ersetzen, die durch den Katarakt eingetrübt wurde. Intraokularlinsen sind für erwachsene Patienten ab 18 Jahren mit Katarakt vorgesehen.

Bei Materialien und Designs von Intraokularlinsen werden erhebliche Fortschritte erzielt. Wir bieten Intraokularlinsen aus verschiedenen Materialtypen an, darunter Polymethacrylat (PMMA) sowie Acrylmaterialien wie hydrophobes (wasserabweisendes) Acryl und hydrophiles (wasseraufnehmendes) Acryl.



Abb. 3: Beispielabbildung einer künstlichen Intraokularlinse

Verschiedene Arten und Leistungsmerkmale von Intraokularlinsen

Derzeit sind aktuellsten unterschiedlichen Typen von Intraokularlinsen erhältlich. Ihr Augenarzt wird mit Ihnen besprechen, welcher Linsentyp für Sie am besten geeignet ist. Zu den Behandlungsoptionen neben einer neuen permanenten Linse gehören Brillen mit dicken Gläsern und Kontaktlinsen. Besprechen Sie die potenziellen Risiken und Vorteile Ihrer Behandlungsmöglichkeiten mit Ihrem Augenarzt.

- **Monofokale Intraokularlinsen**
Monofokale Intraokularlinsen stellen ein klares Sehen in der Ferne wieder her. Das bedeutet, dass Sie beispielsweise bei einer Sportveranstaltung oder beim Lesen entfernter Schilder gut sehen sollten. Für Tätigkeiten im Nahbereich wie Lesen, Schreiben oder Bastelarbeiten werden Sie wahrscheinlich eine Brille benötigen. Möglicherweise benötigen Sie auch eine Brille für Tätigkeiten im mittleren Entfernungsbereich, wie die Arbeit am Computer, das Aufliegen von Make-up oder das Rasieren.
- **Multifokale Intraokularlinsen**
Alle Intraokularlinsen sind grundsätzlich für das Sehen in der Ferne ausgelegt. Multifokale Intraokularlinsen sind jedoch zusätzlich darauf ausgelegt, das Nah- und Intermediarsehen im Vergleich zu einer monofokalen Linse zu verbessern. Das bedeutet, dass Sie sowohl bei einer Sportveranstaltung als auch beim Lesen eines Buches gut sehen sollten. Multifokale Linsen verfügen über unterschiedliche Stärken für das Nahsehen, abgestimmt auf Ihre Lebensgewohnheiten und Bedürfnisse. Insgesamt benötigen Sie für alltägliche Tätigkeiten möglicherweise seltener eine Brille. Allerdings kann die Sehschärfe im Vergleich zu einer monofokalen Linse geringer sein. Dies gilt insbesondere bei schlechten Sichtverhältnissen, wie schwachem Licht oder Nebel. Möglicherweise bemerken Sie auch häufiger Halos (Lichtringe um Lichtquellen) oder Blendungen (reflektiertes Licht, das das Sehen erschwert). Beide Erscheinungen treten bei multifokalen Intraokularlinsen häufig auf.
- **EDoF-Intraokularlinsen (Extended Depth of Focus)**
EDoF-Intraokularlinsen ermöglichen scharfes Sehen von der Ferne bis in den mittleren Entfernungsbereich, beispielsweise auf einem Computerbildschirm. Für Tätigkeiten im Nahbereich, wie das Lesen von Kleingedrucktem oder Präzisionsarbeiten, benötigen Patienten mit EDoF-Linsen möglicherweise eine Lesebrille. Allerdings treten bei ihnen weniger nächtliche Sehstörungen auf, die bei multifokalen Intraokularlinsen manchmal durch helle Lichtquellen verursacht werden. EDoF-Linsen stellen somit eine attraktive Kombination aus größerer Brillenunabhängigkeit als monofokale Intraokularlinsen und weniger potenziellen Nebenwirkungen als multifokale Intraokularlinsen dar.
- **Torische Intraokularlinsen**
Torische Intraokularlinsen stellen bei Patienten mit Astigmatismus ein klares Sehen in der Ferne wieder her. Astigmatismus ist ein verschwommenes oder verzerrtes Sehen, das durch eine unregelmäßig geformte Hornhaut verursacht wird. Wenn Sie an Astigmatismus leiden, kann eine torische Intraokularlinse die richtige Wahl für Sie sein.
- **Multifokale torische Intraokularlinsen**
Multifokale torische Intraokularlinsen sind darauf ausgelegt, Astigmatismus zu korrigieren und gleichzeitig das Sehen in verschiedenen Entfernungen – Fern-, Intermediär- und Nahbereich – zu verbessern. Dadurch können viele alltägliche Tätigkeiten wie Lesen, Arbeiten am Computer oder die Erkennen entfernter Objekte mit geringerer Abhängigkeit von einer Brille durchgeführt werden.

Was Sie vor einer Kataraktoperation erwarten können

Vor der Operation werden Sie untersucht. Dazu gehören die Überprüfung auf Augenerkrankungen sowie die Vermessung Ihres Auges zur Bestimmung der geeigneten Linsenstärke. Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, kann Ihr Augenarzt Sie bitten, diese vor den Untersuchungen nicht mehr zu tragen. Informieren Sie Ihren Augenarzt über alle gesundheitlichen Probleme, die die Operation oder Ihr Sehvermögen beeinflussen könnten. Beispiele hierfür sind Bluthochdruck, Diabetes und Herzkrankheiten. Legen Sie Ihrem Augenarzt eine aktuelle Liste Ihrer Medikamente vor. Planen Sie, dass Sie nach der Operation von einer anderen Person nach Hause gefahren werden.

Was Sie während einer Kataraktoperation erwarten können

Eine Kataraktoperation wird in der Regel ambulant durchgeführt. Sie erhalten ein Betäubungsmittel in Form von Augentropfen, um Ihr Auge zu betäuben. Normalerweise bleiben



it

Foglio Informativo per il Paziente

Tipo di Dispositivo: Lente Intraoculare (Afachica)

Introduzione

La cataratta è una condizione che diventa più comune con l'avanzare dell'età. La cataratta si sviluppa nel tempo quando la lente naturale dell'occhio si irrigidisce e diventa gradualmente opaca. Le persone affette da cataratta sperimentano una visione "sfocata". I colori diventano meno vividi nel tempo e spesso si manifesta una maggiore sensibilità alla luce. Ad esempio, una persona con cataratta probabilmente percepirà un maggiore abbagliamento causato dai fari delle auto in arrivo durante la guida notturna. Senza trattamento, la cataratta finirà per bloccare il passaggio della luce attraverso l'occhio e causare cecità.

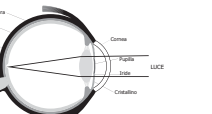


Fig. 1: Anatomia dell'occhio

In che modo la cataratta influisce sulla vista?

La cataratta colpisce il cristallino naturale dell'occhio, chiamato cristallino. Normalmente, questa lente aiuta a focalizzare la luce sulla parte posteriore dell'occhio (la retina), consentendoci di vedere chiaramente. Il cristallino è flessibile e cambia forma per aiutarci a mettere a fuoco sia gli oggetti vicini che quelli lontani. Quando osserviamo qualcosa da vicino, il cristallino si incurva; quando osserviamo qualcosa da lontano, si appiattisce. Questa capacità del cristallino di adattarsi alle diverse distanze è chiamata "accomodazione".

Con l'avanzare dell'età, il cristallino diventa meno flessibile, rendendo più difficile mettere a fuoco gli oggetti vicini: una condizione chiamata presbiopia, che può rendere difficile la lettura dei caratteri piccoli. La cataratta aggiunge un ulteriore problema: il cristallino, normalmente trasparente, diventa gradualmente opaco. Questo rende la visione sfocata nel tempo. Quando la cataratta inizia a compromettere la vista, il cristallino naturale opacizzato deve essere rimosso e sostituito con una lente artificiale mediante intervento chirurgico.

Visione sana

Visione compromessa dalla cataratta

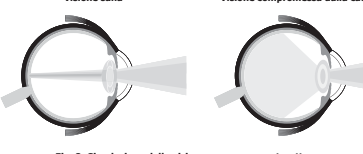


Fig. 2: Simulazione della visione senza e con cataratta

Che cos'è una Lente Intraoculare (LIO)?

Attualmente sono disponibili diversi tipi di lenti. Il vostro oculista discuterà con voi quale tipo di lente sia il più adatto alle vostre esigenze. Le alternative a una nuova lente permanente includono occhiali con lenti spesse e lenti a contatto. Discutete con il vostro oculista i potenziali rischi e benefici delle diverse opzioni di trattamento.

- **LIO Monofocali**
Le LIO monofocali ripristinano una visione nitida da lontano. Ciò significa che dovrete vedere bene quando assistete a un evento sportivo sia quando leggete un libro. Le lenti multifocali hanno diversi poteri per la visione da vicino, in base alle esigenze del vostro stile di vita. Nel complesso, potreste utilizzare gli occhiali meno frequentemente nelle attività quotidiane. Tuttavia, la nitidezza della visione potrebbe risultare inferiore rispetto a quella ottenuta con una lente monofocale. Questo accade soprattutto in condizioni di scarsa visibilità, come luce debbole o nebbia. Potreste inoltre notare più aloni (anelli intorno alle fonti luminose) o abbagliamento (luce riflessa che rende difficile vedere chiaramente). Entrambi questi fenomeni sono comuni con le LIO multifocali.
- **LIO EDoF (Extended Depth of Focus)**
Le LIO EDoF consentono una visione nitida dalle lunghe alle medie distanze, ad esempio su uno schermo di computer. Per attività ravvicinate come la lettura di caratteri molto piccoli o lavori di precisione, i pazienti implantati con lenti EDoF potrebbero aver bisogno di occhiali da lettura. Tuttavia, sperimenteranno meno disturbi visivi durante la notte, che talvolta possono essere causati da fonti luminose intense nelle LIO multifocali. Le lenti EDoF rappresentano quindi una combinazione vantaggiosa tra una maggiore indipendenza dagli occhiali rispetto alle LIO monofocali e un minor numero di potenziali effetti indesiderati rispetto alle LIO multifocali.
- **LIO Toriche**
Le LIO toriche ripristinano una visione nitida da lontano nei pazienti affetti da astigmatismo. L'astigmatismo è una visione sfocata o distorta causata da una forma irregolare della cornea. Se soffrite di astigmatismo, una LIO torica potrebbe essere la scelta più adatta per voi.
- **LIO Toriche Multifocali**
Le lenti intraoculari toriche multifocali sono progettate per correggere l'astigmatismo e contemporaneamente migliorare la visione a diverse distanze, comprese quelle lontane, intermedie e vicino. Ciò può consentirvi di svolgere molte attività quotidiane, come leggere, utilizzare un computer o vedere oggetti distanti, riducendo la dipendenza dagli occhiali.

Cosa aspettarsi prima dell'intervento di cataratta

Prima dell'intervento sarete sottoposti a una valutazione. Questa comprende il controllo di eventuali patologie oculari e la misurazione dell'occhio per determinare il corretto potere diottrico della lente. Se portate lenti a contatto, il vostro oculista potrebbe chiedervi di interrompere l'uso prima degli esami. Informate il vostro oculista di eventuali condizioni di salute che potrebbero influenzare l'intervento o la vostra vista. Alcuni esempi includono ipertensione arteriosa, diabete e malattie cardiache. Fornite al vostro oculista un elenco aggiornato dei farmaci che assumete. Organizzatevi affinché qualcuno vi accompagni a casa dopo l'intervento.

Cosa aspettarsi durante l'intervento di cataratta

L'intervento di cataratta viene generalmente eseguito in regime ambulatorio. Vi verrà somministrata un'anestesia sotto forma di collirio per anestetizzare l'occhio. Normalmente rimarrete completamente svegli durante l'intervento. Dovrete avvertire poco o nessun disagio. L'oculista utilizzerà un microscopio per ottenere una visione ingrandita del vostro occhio. Il cristallino naturale si trova in una struttura simile a un sacco chiamata capsula del cristallino. La capsula del cristallino è situata appena dietro la parte colorata dell'occhio (iride). Una foraticista una piccola incisione sulla superficie esterna dell'occhio. Attraverso questa apertura, l'oculista inserisce una piccola sonda per frammentare il cristallino opacizzato dalla cataratta.



pt

FOLHETO INFORMATIVO PARA O PACIENTE

Tipo de Dispositivo: Lente Intraocular (Afáquica)

Introdução

A catarata é uma condição que se torna mais comum com o avançar da idade. A catarata forma-se ao longo do tempo à medida que a lente natural do olho se endurece e se torna gradualmente opaca. As pessoas com cataratas apresentam uma visão "turva". As cores tornam-se menos vivas com o tempo e existe frequentemente uma maior sensibilidade à luz. Por exemplo, uma pessoa com cataratas provavelmente experimentará um maior encandecimento provocado pelos faróis dos veículos que se aproximam durante a noite. Sem tratamento, a catarata acabará por bloquear a passagem da luz através do olho e causar cegueira.

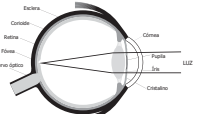


Fig. 1: Anatomia do olho

Como é que a catarata afeta a sua visão?

A catarata afeta a lente natural do olho, denominada cristallino. Normalmente, esta lente ajuda a focar a luz na parte posterior do olho (a retina), permitindo-nos ver com nitidez. O cristallino é flexível e altera a sua forma para nos ajudar a focar objetos tanto próximos como distantes. Quando observamos algo próximo, o cristallino torna-se mais curvo; quando observamos algo distante, torna-se mais plano. Esta capacidade de adaptação do cristallino a diferentes distâncias denomina-se "acomodação".

À medida que envelhecemos, o cristallino torna-se menos flexível, tornando mais difícil focar objetos próximos — uma condição denominada presbiopia, que pode dificultar a leitura de letras pequenas. A catarata acrescenta outro problema: o cristallino, normalmente transparente, torna-se gradualmente opaco. Isto provoca uma visão desfocada ao longo do tempo. Quando as cataratas começam a afetar a visão, o cristallino natural opacificado necessita de ser removido e substituído por uma lente artificial através de cirurgia.

Visão saudável

Visão comprometida pela catarata

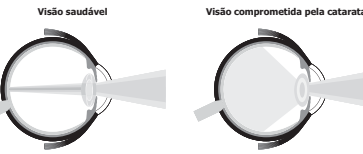


Fig. 2: Simulação da visão sem e com catarata

O que é uma Lente Intraocular (LIO)?

As lentes intraoculares são lentes artificiais utilizadas na cirurgia moderna da catarata. São implantadas no saco capsular para substituir o cristallino humano opacificado por a catarata. As lentes intraoculares estão indicadas para pacientes adultos com idade igual ou superior a 18 anos com catarata.

Tem havido avanços significativos nos materiais e nos desenhos das lentes intraoculares. Disponibilizamos lentes intraoculares de diferentes tipos de materiais, incluindo polimetilmetacrilato (PMMA), materiais acrílicos como o acrílico hidrofóbico (repelente de água) e o acrílico hidrofílico (absorvente de água).



Fig. 3: Imagem representativa de uma Lente Intraocular Artificial

Diferentes tipos e desempenho das LIO

Atualmente existem diferentes tipos de lentes disponíveis. O seu oftalmologista irá discutir qual o tipo de lente mais adequado para si. As opções de tratamento além de uma nova lente permanente incluem óculos com lentes espessas e lentes de contacto. Discuta os potenciais riscos e benefícios das suas opções de tratamento com o seu oftalmologista.

- **LIO Monofocais**
As LIO monofocais restauram uma visão nítida ao longe. Isto significa que deverá ver bem quando assiste a um evento desportivo ou lê sinais de trânsito. Provavelmente necessitará gafas para tarefas de visão próxima, como ler um livro, escrever ou realizar trabalhos manuais. Poderá também necessitar de óculos para atividades de visão intermédia, como trabalhar ao computador, maquiar-se ou fazer a barba.
- **LIO Multifocais**
Todas as LIO são geralmente concebidas para a visão ao longe. No entanto, as LIO multifocais também são concebidas para melhorar a visão próxima e intermédia em comparação com uma lente monofocal. Isto significa que deverá ver bem tanto quando assiste a um evento desportivo como quando lê um livro. As lentes multifocais tienen diferentes potencias para a visão próxima, com base nas necessidades do seu estilo de vida. Em geral, poderá usar óculos com menos frequência nas tarefas diárias. No entanto, a nitidez da sua visão poderá também diminuir em comparação com uma lente monofocal. Isto acontece especialmente em condições de visibilidade reduzida, como luz fraca ou nevoeiro. Poderá também notar mais halos (anéis em redor das luzes) ou encandecimento (luz refletida que dificulta a visão). Ambos são comuns com as LIO multifocais.
- **LIO EDoF (Profundidade de Foco Estendida)**
Permitem uma visão nítida desde longas distâncias até distâncias intermédias, como a visualização de um monitor de computador. Para atividades de proximidade, como a leitura de letras pequenas e trabalhos de precisão, os pacientes implantados com lentes EDoF poderão necessitar de usar óculos de leitura. No entanto, terão menos perturbações visuais durante a noite, que por vezes são causadas por fontes de luz intensa nas LIO multifocais. As lentes EDoF representam assim uma combinação atrativa de maior independência dos óculos do que as LIO monofocais e menos potenciais efeitos secundários do que as LIO multifocais.
- **LIO Tóricas**
As LIO tóricas restauram uma visão nítida ao longe em pacientes com astigmatismo. O astigmatismo é uma visão desfocada ou distorcida causada por uma córnea com forma irregular. Se tiver astigmatismo, uma LIO torica poderá ser a escolha adequada para si.
- **LIO Tóricas Multifocais**
As lentes intraoculares tóricas multifocais foram concebidas para corrigir o astigmatismo e simultaneamente melhorar a visão a múltiplas distâncias, incluindo longe, intermédia e perto. Isto pode permitir-lhe realizar muitas atividades diárias, como ler, utilizar um computador ou ver objetos distantes, com menor dependência de óculos.

O que esperar antes da cirurgia às cataratas

Será avaliado antes da cirurgia. Esta avaliação inclui a verificação de quaisquer doenças oculares e a medição do seu olho para determinar a potência correta da lente. Se utilizar lentes de contacto, o seu oftalmologista poderá pedir-lhe que deixe de as usar antes da realização dos exames. Informe o seu oftalmologista sobre quaisquer problemas de saúde que possam afectar a cirurgia ou a sua visão. Exemplos incluem hipertensão arterial, diabetes e doença cardíaca. Forneça ao seu oftalmologista uma lista atualizada dos medicamentos que toma. Planeie que outra pessoa o leve para casa após a cirurgia.

O que esperar durante a cirurgia às cataratas

A cirurgia às cataratas é normalmente realizada em regime ambulatorio. Ser-lhe-á administrada anestesia sob a forma de gotas oftálmicas para anestesiar o olho. Normalmente, permanecerá totalmente acordado durante a cirurgia. É expectável sentir pouco ou nenhum desconforto. O seu oftalmologista utilizará um microscópio para obter uma visão ampliada do seu olho. O seu cristallino natural encontra-se dentro de uma estrutura semelhante a um saco denominada capsula do cristallino. A capsula do cristallino está situada justo detrás de uma parte colorada do olho (iris). Se realiza uma pequena incisão na superfície externa do olho. O oftalmologista introduz uma pequena sonda a través de esta abertura para fragmentar o cristallino afectado por a catarata. A



es

FOLLETO DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Tipo de dispositivo: Lente Intraocular (Afáquica)

Introducción

La catarata es una afección que se vuelve más frecuente con la edad. Una catarata se desarrolla con el tiempo a medida que el cristallino natural del ojo se endurece y se vuelve gradualmente opaco. Las personas con cataratas experimentan una visión "nublada". Los colores se vuelven menos vivos con el tiempo y suele haber una mayor sensibilidad a la luz. Por ejemplo, una persona con cataratas probablemente experimentará un mayor deslumbramiento causado por los faros de los vehículos que se aproximan durante la noche. Sin tratamiento, la catarata acabará bloqueando el paso de la luz a través del ojo y provocará ceguera.

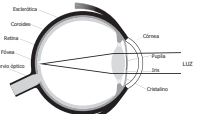


Fig. 1: Anatomía del ojo

¿Cómo afecta la catarata a su visión?

La catarata afecta al cristallino natural del ojo. Normalmente, este cristallino ayuda a enfocar la luz sobre la parte posterior del ojo (la retina) para que podamos ver con claridad. El cristallino es flexible y cambia de forma para ayudarnos a enfocar objetos tanto cercanos como lejanos. Cuando observamos algo cercano, el cristallino se curva; cuando observamos algo lejano, se aplan. Esta capacidad del cristallino para ajustarse a diferentes distancias se denomina "acomodación".

A medida que envejecemos, el cristallino se vuelve menos flexible, lo que dificulta enfocar objetos cercanos; esta condición se denomina presbicia y puede dificultar la lectura de textos con letra pequeña. La catarata añade otro problema: el cristallino, que normalmente es transparente, se vuelve gradualmente opaco. Esto provoca una visión borrosa con el tiempo. Cuando las cataratas comienzan a afectar la visión, es necesario extraer el cristallino natural opaco y reemplazarlo por una lente artificial mediante cirugía.

Visión saludable

Visión afectada por catarata



Fig. 2: Simulación de la visión sin y con catarata

¿Qué es una Lente Intraocular (LIO)?

Las lentes intraoculares son lentes artificiales utilizadas en la cirugía moderna de cataratas. Se implantan en el saco capsular para sustituir el cristallino humano opacificado por la catarata. Las lentes intraoculares están indicadas para pacientes adultos de 18 años o más con cataratas. Se han producido importantes avances en los materiales y diseños de las lentes intraoculares. Ofrecemos lentes intraoculares de diferentes tipos de materiales, incluidos: polimetilmetacrilato (PMMA), materiales acrílicos como el acrílico hidrofóbico (repelente al agua) y el acrílico hidrofílico (absorbente de agua).



Fig. 3: Imagen representativa de una lente intraocular artificial

Diferentes tipos y rendimiento de las LIO

Actualmente existen diferentes tipos de lentes disponibles. Su oftalmólogo le explicará qué tipo de lente es la más adecuada para usted.

Las opciones de tratamiento distintas de una nueva lente permanente incluyen gafas con lentes gruesas y lentes de contacto. Comente con su oftalmólogo los posibles riesgos y beneficios de las distintas opciones de tratamiento.

- **LIO Monofocales**
Las LIO monofocales restauran una visión clara a distancia. Esto significa que debería ver bien cuando asista a un evento deportivo o le señales lejanas. Probablemente necesitará gafas para tareas de visión cercana, como leer un libro, escribir o realizar manualidades. También puede necesitar gafas para actividades de visión intermedia, como trabajar con un ordenador, maquillarse o afeitarse.
- **LIO Multifocales**
Todas las LIO están generalmente diseñadas para la visión de lejos. Sin embargo, las LIO multifocales también están diseñadas para mejorar la visión de cerca y de intermedia en comparación con una lente monofocal. Esto significa que debería ver bien tanto cuando asista a un evento deportivo como cuando lea un libro. Las lentes multifocales tienen diferentes potencias para la visión cercana, según las necesidades de su estilo de vida. En general, es posible que necesite usar gafas con menos frecuencia para las tareas diarias. Sin embargo, la nitidez de su visión también puede disminuir en comparación con una lente monofocal. Esto ocurre especialmente en condiciones de baja visibilidad, como luz tenue o niebla. También puede notar más halos (anillos alrededor de las luces) o deslumbramientos (luz reflejada que dificulta la visión). Ambos fenómenos son comunes con las LIO multifocales.
- **LIO EDoF (Profundidad de Enfoque Extendida)**
Permiten una visión nítida desde distancias lejanas hasta intermedias, como la distancia de una pantalla de ordenador. Para actividades de cerca, como leer letra pequeña o realizar trabajos de precisión, los pacientes implantados con lentes EDoF pueden necesitar gafas de lectura. Sin embargo, experimentarán menos alteraciones visuales durante la noche, que a veces son causadas por fuentes de luz intensa en las LIO multifocales. Por ello, las lentes EDoF representan una combinación atractiva de mayor independencia de las gafas que las LIO monofocales y menos efectos secundarios potenciales que las LIO multifocales.
- **LIO Tóricas**
Las LIO tóricas restauran una visión clara a distancia en pacientes con astigmatismo. El astigmatismo es una visión borrosa o distorsionada causada por una córnea de forma irregular. Si tiene astigmatismo, una LIO torica puede ser la elección adecuada para usted.
- **LIO Tóricas Multifocales**
Las lentes intraoculares tóricas multifocales están diseñadas para corregir el astigmatismo y, al mismo tiempo, mejorar la vista a múltiples distancias, incluyendo la lejana, la intermedia y la cercana. Esto puede permitirle realizar muchas actividades cotidianas, como leer, utilizar un ordenador o ver objetos distantes, reduciendo la dependencia de las gafas.

Qué esperar antes de la cirugía de cataratas

Será evaluado antes de la cirugía. Esto incluye la comprobación de posibles enfermedades oculares y la medición de su ojo para determinar la potencia correcta de la lente. Si utiliza lentes de contacto, su oftalmólogo puede pedirle que deje de usarlas antes de realizar las pruebas. Informe a su oftalmólogo si padece alguna afección médica que pueda afectar a la cirugía o a su visión. Algunos ejemplos son la hipertensión arterial, la diabetes y las enfermedades cardíacas. Proporcione a su oftalmólogo una lista actualizada de los medicamentos que toma. Planifique que otra persona le lleve a casa después de la cirugía.

Qué esperar durante la cirugía de cataratas

La cirugía de cataratas suele realizarse como un procedimiento ambulatorio. Se le administrará anestesia en forma de gotas oftálmicas para adormecer el ojo. Normalmente permanecerá completamente despierto durante la cirugía. Puede sentir poco o ninguna molestia. Su oftalmólogo utilizará un microscopio para obtener una visión ampliada de su ojo. Su cristallino natural se encuentra dentro de una estructura similar a una bolsa denominada capsula del cristallino. La capsula del cristallino está situada justo detrás de la parte coloreada del ojo (iris). Se realiza una pequeña incisión en la superficie externa del ojo. El oftalmólogo introduce una pequeña sonda a través de esta abertura para fragmentar el cristallino afectado por la catarata. A

What to expect after cataract surgery

Right after surgery, you should stay in the recovery area for a short time. Your eye doctor should give you an identification card (typically called implant card) to keep in your wallet. This card shows the type of implant in your eye. Present this card to any eye doctor who examines your eyes after surgery.

Many patients may begin to see better within 1 to 2 days. Some are stable at 10 to 14 days. Some may take 4 to 6 weeks to recover from surgery. Improvements in vision are different for each person.

Call your eye doctor right away if you experience any itching, pain, flashing lights, “floaters”, redness, severe headache, nausea/vomiting, light sensitivity, or watery eyes after surgery.

Instructions for post-operative care

You are allowed to return home on the same day after surgery. Your eye doctor will give you antibiotic eye drops and medicines to speed up healing and to prevent infection. Take all prescribed medicines and apply eye drops as instructed by your eye doctor.

For the first week after surgery, do not go swimming or use a bath or hot tub to help prevent infection. Also try to protect your eye from things like dirt, dust, and strong wind. Keep the eyes protected with sunglasses as much as possible and sleep with your eye shield at night. You should avoid rubbing your eye or putting extra pressure on it. You will be given a date and time for a follow-up visit. It is typically the next day. Your doctor will examine you several more times following your surgery depending on the speed of healing. It may take you some time to get used to new IOL.

Talk to your eye doctor if you have any questions or concerns after surgery.

Undesirable side effects, warnings and residual risk

■ Visual light phenomena

After cataract surgery, some patients may notice glare or halos, especially in low light. Halos appear as bright rings around lights, while glare is bright light that can affect clear vision. These effects may be more noticeable when driving at night or looking at artificial lights. In most cases, these effects improve within a few weeks or months as the brain adapts to the intraocular lens. If they continue after healing, consult your ophthalmologist. Always follow your surgeon's instructions and report any unusual symptoms.

■ Decentration or deviating dioptr power of the lens:

In rare cases, the implanted lens may move slightly from its position in the eye, even years after surgery. This can cause visual disturbances or glare, which can usually be corrected with a surgical procedure.

Sometimes the lens power may not perfectly match the eye, which can affect vision. This may happen if the lens does not settle exactly as predicted or due to small calculation differences. In most cases, the effect is minor. If the difference is larger, it can usually be corrected with glasses, contact lens, lasik or surgery.

Inform your doctor if you experience:

- a strong pain in your eye
- recurring redness of the eye
- unusual headache or nausea
- considerable vision deterioration
- light flashes, or huge increase of floaters in your eye

These are rare complications that may occur shortly after surgery.

■ Infections and minor complications

As with any surgery, there is a small risk of infection after cataract surgery, although serious complications are rare. If an infection occurs, it can usually be treated with prescribed eye drops. You should contact your ophthalmologist if your eye becomes swollen or if you notice any unusual symptoms.

Some minor complications may include:

- Swelling
- Increased pressure in the eye
- Dropsy eyelid

These conditions are usually temporary and improve with medication and proper healing. Inform your ophthalmologist immediately if you notice any changes so your recovery can be monitored and treated if needed.

■ Posterior capsule opacification

Posterior capsule opacification (PCO) is a common condition that may occur after cataract surgery. It happens when some remaining lens cells grow on the thin membrane behind the implanted lens, causing vision to become cloudy again. Although it is sometimes called a “secondary cataract,” it is not a new cataract.

PCO can be easily treated with a quick and painless Nd: YAG laser procedure performed by your ophthalmologist. The treatment usually takes only a few minutes, and most patients notice improved vision within a day. If your vision becomes blurry again after surgery, contact your ophthalmologist for further advice.

Magnetic Resonance Compatibility:

The implanted IOL does not contain any metallic components and are safe with no potential for interaction with the Magnetic Resonance (MR) Field. IOL is safer for Magnet Resonance Imaging (MRI) at a magnetic field strength of 1.5 and 3.0 Tesla.

Expected lifetime and necessary follow-up

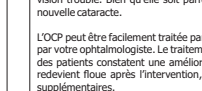
The IOL will usually last for a patient's lifetime. Should you however encounter any deterioration in your vision quality, please consult your eye doctor for further investigation and treatment. Your eye doctor will discuss with you about the necessary follow-up intervals based on your medical condition.

Reporting of serious incidents

Any serious incident that occurs in relation to the intraocular lens should be reported to your doctor (in the first instance), to the local representative or to the EYEOU U.K. LIMITED.

About this document:

Your ophthalmologist has performed the cataract surgery and implanted the intraocular lenses (IOL) in your eye. The patient implant card and leaflet have been given to you after the catarar surgery. Please always carry the patient implant card with you to facilitate medical care in case of emergency. The link provided on the implant card will provide you latest updates about the IOL.

		
8 Apex Business Centre, Boscombe Road, Dunstable, Bedfordshire, L15 4SB, UK Tel: +44 (0) 1582 477 002 Fax: +44 (0) 1582 607 009 E-Mail: info@eyeoel.co.uk Web: www.eyeoel.co.uk	Bd. Général Walsby, 53 1030 Bruxelles, Belgique Tel.: +32-2.732.59.54 Fax: +32-2.732.60.03 Email: mail@obelis.net Web: www.obelis.net	

Àquoi s’attendre pendant la chirurgie de la cataracte

La chirurgie de la cataracte est généralement réalisée en ambulatoire. Une anesthésie sous forme d’injection oculaire sera administrée afin d’insensibiliser votre œil. En règle générale, vous resterez pleinement éveillé pendant l’intervention. Vous ne devriez ressentir que peu ou pas d’inconfort. Votre ophthalmologiste utilisera un microscope afin d’obtenir une vue agrandie de votre œil. Votre cristallin naturel est situé dans une structure en forme de sac appelée capsule cristallinienne. La capsule cristallinienne se trouve juste derrière la partie colorée de l’œil (l’iris). Une petite incision est pratiquée à la surface externe de l’œil. L’ophthalmologiste introduit une minuscule sonde à travers cette ouverture afin de fragmenter le cristallin cataracté. Il utilise ensuite un petit dispositif d’aspiration pour retirer les fragments de cataracte de votre œil. Un espace est alors disponible pour l’implantation de la LIO dans votre œil, afin de remplacer le cristallin naturel. Votre ophthalmologiste vient de retirer. Votre médecin introduira la LIO à travers la même petite incision. Une fois l’intervention terminée, votre ophthalmologiste pourra placer un pansement ou une coque de protection sur votre œil.

Àquoi s’attendre après la chirurgie de la cataracte

Immédiatement après l’intervention, vous devriez attendre quelque temps dans la zone de récupération. Votre ophthalmologiste devra vous remettre une carte d’identification (généralement appelée carte d’implant) à conserver dans votre portefeuille. Cette carte est une photo d’implant présent dans votre œil. Présenter cette carte à tout ophthalmologiste qui examinera vos yeux après l’intervention.

De nombreux patients commencent à mieux voir dans un délai de 1 à 2 jours. Chez certains, la vision se stabilise au bout de 10 à 14 jours. D’autres peuvent nécessiter 4 à 6 semaines pour récupérer complètement après l’intervention. L’amélioration de la vision varie d’une personne à l’autre.

Contactez immédiatement votre ophthalmologiste si vous sentez des dérangements, des douleurs, des éclairs lumineux, des « corps flottants », une rougeur, de forts maux de tête, des nausées/vomissements, une sensibilité à la lumière ou un larmoiement après l’intervention.

Instructions relatives aux soins postopératoires

Vous pourrez rentrer chez vous le jour même de l’intervention. Votre ophthalmologiste vous prescrira des collyres antibiotiques et des médicaments destinés à accélérer la cicatrisation et à prévenir les infections. Prenez tous les médicaments prescrits et appliquez les collyres conformément aux instructions de votre ophthalmologiste.

Pendant la première semaine suivant l’intervention, évitez de nager ainsi que l’utilisation d’une baignoire ou d’un bain à remous afin de prévenir les infections. Essayez également de protéger votre œil de la saleté, de la poussière et des vents forts. Gardez vos yeux protégés avec des lunettes de soleil autant que possible et portez votre coque de protection oculaire pendant la nuit. Vous devez éviter de vous frotter l’œil ou d’exercer une pression supplémentaire sur celui-ci. Une date et une heure vous seront communiquées pour une visite de suivi, généralement le lendemain de l’intervention. Votre médecin vous examinera plusieurs fois après l’opération en fonction de la vitesse de cicatrisation. Il peut vous falloir un certain temps pour vous habituer à votre nouvelle LIO.

Parlez à votre ophthalmologiste si vous avez des questions ou des préoccupations après l’intervention.

Effets indésirables, avertissements et risques résiduels

■ Phénomènes lumineux visuels

Après une chirurgie de la cataracte, certains patients peuvent remarquer des éblouissements ou des halos, particulièrement dans des conditions de faible luminosité. Les halos apparaissent sous forme d’anneaux lumineux autour des sources de lumière, tandis que l’éblouissement correspond à une lumière intense pouvant altérer la qualité de la vision. Ces effets peuvent être plus perceptibles lors de la conduite de nuit ou lors de l’observation de lumières artificielles.

Dans la plupart des cas, ces effets s’améliorent au bout de quelques semaines ou de quelques mois à mesure que le cerveau s’adapte à la nouvelle intraoculaire. Si ces phénomènes persistent après la période de cicatrisation, consultez votre ophthalmologiste. Suivez toujours les instructions de votre chirurgien et signalez tout symptôme inhabituel.

■ Décentrement ou puissance dioptrique inadéquate de la lentille

Dans de rares cas, la lentille implantée peut se déplacer légèrement de sa position dans l’œil, même plusieurs années après l’intervention. Cela peut entraîner des perturbations visuelles ou un éblouissement, qui peuvent généralement être corrigés par une intervention chirurgicale. Il arrive parfois que la puissance de la lentille ne corresponde pas parfaitement à l’œil, ce qui peut affecter la vision. Cela peut se produire si la lentille ne se positionne pas exactement comme prévu ou en raison de légères différences de calcul. Dans la plupart des cas, l’effet est mineur. Si l’cart est plus important, il peut généralement être corrigé par des lunettes, des lentilles de contact, une intervention LASIK ou une chirurgie.

Informez votre médecin si vous présentez :

- une douleur importante dans l’œil ;
- une rougeur récurrente de l’œil ;
- des maux de tête inhabituels ou des nausées ;
- une détérioration importante de la vision ;
- des éclairs lumineux ou une augmentation importante du nombre de corps flottants dans votre œil.

Il s’agit de complications rares pouvant survenir peu après l’intervention.

■ Infections et complications mineures

Comme pour toute intervention chirurgicale, il existe un faible risque d’infection après une chirurgie de la cataracte, bien que les complications graves soient rares. En cas d’infection, celle-ci peut généralement être traitée à l’aide de collyres prescrits. Vous devez contacter votre ophthalmologiste si votre œil devient écarlate ou si vous remarquez des symptômes inhabituels.

Certaines complications mineures peuvent inclure :

- un gonflement ;
- une augmentation de la pression intraoculaire ;
- une chute de la paupière.

Ces affections sont généralement temporaires et s’améliorent grâce aux médicaments et à une cicatrisation appropriée. Informez immédiatement votre ophthalmologiste si vous remarquez des changements afin que votre rétablissement puisse être surveillé et traité si nécessaire.

■ Opacification de la capsule postérieure

L’opacification de la capsule postérieure (OCP) est une affection fréquente qui peut survenir après une chirurgie de la cataracte. Elle se produit lorsque certaines cellules résiduelles du cristallin prolifèrent sur la fine membrane située derrière la lentille implantée, provoquant à nouveau une vision trouble. Bien qu’elle soit parfois appelée « cataracte secondaire », il ne s’agit pas d’une nouvelle cataracte.

L’OCP peut être facilement traitée par une intervention rapide et indolore au laser Nd:YAG réalisée par votre ophthalmologiste. Le traitement ne dure généralement que quelques minutes et la plupart des patients constatent une amélioration de leur vision dans la journée qui suit. Si votre vision ne revient tout d’abord après l’intervention, contactez votre ophthalmologiste pour obtenir des conseils supplémentaires.

Compatibilité avec la résonance magnétique

La LIO implantée ne contient aucun composant métallique et ne présente aucun risque d’interaction avec le champ de résonance magnétique (RM). La LIO est compatible avec l’imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée à des intensités de champ magnétique de 1,5 et 3,0 Tesla.

Durée de vie attendue et suivi nécessaire

La LIO est généralement conçue pour durer toute la vie du patient. Toutefois, si vous constatez une détérioration de la qualité de votre vision, veuillez consulter votre ophthalmologiste afin de procéder à des examens complémentaires et à un traitement approprié. Votre ophthalmologiste discutera avec vous de la fréquence des consultations de suivi nécessaires en fonction de votre état de santé.

Sie während des Eingriffs vollständig wach. Sie sollten nur geringe oder keine Beschwerden verspüren. Ihr Augenarzt verwendet ein Mikroskop, um Ihr Auge vergrößert betrachten zu können. Ihre natürliche Linse befindet sich in einer sackartigen Struktur, die als LinsenkapSEL bezeichnet wird. Die LinsenkapSEL befindet sich direkt hinter dem farbigen Teil Ihres Auges (Iris). An der äußeren Oberfläche des Auges wird ein kleiner Schnitt vorgenommen. Durch diese Öffnung führt der Augenarzt eine winzige Sonde ein, um die eingebrütete Linse zu zerkleinern. Anschließend werden die Kataraktfragmente mit einem kleinen vakuumpumpierten Instrument aus dem Auge entfernt. Danach stellt der Augenarzt ein Instrument ein, um die Linse zu entfernen und sie durch eine Linse einzusetzen und die zuvor entfernte natürliche Linse zu ersetzen. Ihr Arzt setzt die Intraokularlinse durch denselben kleinen Schnitt ein. Nach Abschluss der Operation kann Ihr Augenarzt einen schützenden Verband oder eine Schutzschale über Ihr Auge legen.

Was Sie nach einer Kataraktoperation erwarten können

Unmittelbar nach der Operation sollten Sie für kurze Zeit im Aufwachbereich bleiben. Ihr Augenarzt sollte Ihnen eine Identifikationskarte (üblicherweise Implantatkarte genannt) aushändigen, die Sie in Ihrer Brieftasche aufbewahren sollten. Diese Karte enthält Angaben zum Typ des in Ihrem Auge eingesetzten Glases. Zeigen Sie diese Karte jedem Augenarzt vor, der Ihre Augen nach der Operation untersucht.

Viele Patienten bemerken bereits innerhalb von 1 bis 2 Tagen eine Verbesserung ihres Sehvermögens. Bei einigen stabilisiert sich das Sehvermögen nach 10 bis 14 Tagen. Andere benötigen 4 bis 6 Wochen, um sich vollständig von der Operation zu erholen. Die Verbesserung des Sehvermögens ist von Person zu Person unterschiedlich.

Wenden Sie sich sofort an Ihren Augenarzt, wenn Sie nach der Operation Juckreiz, Schmerzen, Scherelle, „fliegende Mücken“ (Floaters), Rötungen, starke Kopfschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Lichtempfindlichkeit oder tränende Augen auftreten.

Anweisungen zur postoperativen Nachsorge

Sie können am selben Tag nach der Operation nach Hause zurückkehren. Ihr Augenarzt wird Ihnen antibiotische Augentropfen und Medizin verschreiben, um die Heilung zu beschleunigen und Infektionen vorzubeugen. Nehmen Sie alle verordneten Medikamente ein und wenden Sie die Augentropfen gemäß den Anweisungen Ihres Augenarztes an.

Vermeiden Sie in der ersten Woche nach der Operation das Schwimmen sowie die Benutzung von Badebecken oder Whirlpools, um Infektionen vorzubeugen. Versuchen Sie außerdem, Ihr Auge vor Schutz, Staub und starkem Wind zu schützen. Tragen Sie möglichst häufig eine Sonnenbrille zum Schutz Ihrer Augen und verwenden Sie nachts die Augenschutzschale. Vermeiden Sie es, Ihr Auge zu reiben oder zusätzlichen Druck darauf auszuüben. Sie erhalten einen Termin für eine Nachuntersuchung, die in der Regel am nächsten Tag stattfindet. Je nach Heilungsverlauf wird Ihr Arzt Ihr Auge nach der Operation noch mehrere Male untersuchen. Es kann einige Zeit dauern, bis Sie sich an die neue Intraokularlinse gewöhnt haben.

Sprechen Sie mit Ihrem Augenarzt, wenn Sie nach der Operation Fragen oder Bedenken haben.

Vermeiden Sie sich sofort an Ihren Augenarzt, wenn Sie nach der Operation Juckreiz, Schmerzen, Scherelle, „fliegende Mücken“ (Floaters), Rötungen, starke Kopfschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Lichtempfindlichkeit oder tränende Augen auftreten.

Vermeiden Sie in der ersten Woche nach der Operation das Schwimmen sowie die Benutzung von Badebecken oder Whirlpools, um Infektionen vorzubeugen. Versuchen Sie außerdem, Ihr Auge vor Schutz, Staub und starkem Wind zu schützen. Tragen Sie möglichst häufig eine Sonnenbrille zum Schutz Ihrer Augen und verwenden Sie nachts die Augenschutzschale. Vermeiden Sie es, Ihr Auge zu reiben oder zusätzlichen Druck darauf auszuüben. Sie erhalten einen Termin für eine Nachuntersuchung, die in der Regel am nächsten Tag stattfindet. Je nach Heilungsverlauf wird Ihr Arzt Ihr Auge nach der Operation noch mehrere Male untersuchen. Es kann einige Zeit dauern, bis Sie sich an die neue Intraokularlinse gewöhnt haben.

Sprechen Sie mit Ihrem Augenarzt, wenn Sie nach der Operation Fragen oder Bedenken haben.

Unwünschte Nebenwirkungen, Warnhinweise und Restrisiken
■ Visuelle Lichtphänomene
Nach einer Kataraktoperation können einige Patienten Blendungen oder Halos bemerken, insbesondere bei schwachen Lichtverhältnissen. Halos erscheinen als helle Ringe um Lichtquellen, während Blendungen als starkes Licht wahrgenommen werden, das das klare Sehen beeinträchtigen kann. Diese Effekte können besonders beim nächtlichen Autofahren oder beim Blick auf künstliche Lichtquellen auftreten.

In den meisten Fällen verbessern sich diese Erscheinungen innerhalb weniger Wochen oder Monate, während sich das Gehirn an die Intraokularlinse anpasst. Sollten die Symptome nach Abschluss der Heilungsphase weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Augenarzt. Befolgen Sie stets die Anweisungen Ihres Chirurgen und melden Sie ungewöhnliche Symptome.

■ Dezentrierung oder abweichende Dioptrienstärke der Linse
In seltenen Fällen kann sich die implantierte Linse auch Jahre nach der Operation geringfügig aus ihrer Position im Auge verschieben. Dies kann Sehstörungen oder Blendungen verursachen, die in der Regel durch einen chirurgischen Eingriff korrigiert werden können. Manchmal entspricht die Linsenstärke nicht exakt den Anforderungen des Auges, was das Sehvermögen beeinträchtigen kann. Dies kann auftreten, wenn sich die Linse nicht genau wie vorhergesehen positioniert oder wenn sich die Berechnungen für die Linse in den ersten Wochen nach der Operation ändern. Diese Abweichungen können durch eine Nachuntersuchung und gegebenenfalls eine Korrektur der Linsestärke (z. B. durch Kontaktlinsen, LASIK oder eine chirurgische Korrektur) behoben werden.

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn bei Ihnen Folgendes auftritt:

- starke Schmerzen im Auge
- wiederkehrende Augenrötungen
- ungewöhnliche Kopfschmerzen oder Übelkeit
- erhebliche Verschlechterung des Sehvermögens
- Lichtblitze oder eine starke Zunahme von „fliegenden Mücken“ (Floaters) im Auge

Dies sind seltene Komplikationen, die kurz nach der Operation auftreten können.

■ Infektionen und geringfügige Komplikationen

Wie bei jeder Operation besteht auch nach einer Kataraktoperation ein geringes Infektionsrisiko, obwohl schwerwiegende Komplikationen selten sind. Tritt eine Infektion auf, kann sie in der Regel mit verschriebenen Augentropfen behandelt werden. Sie sollten Ihren Augenarzt kontaktieren, wenn Ihr Auge anschwillt oder wenn Sie ungewöhnliche Symptome bemerken.

Zu den geringfügigen Komplikationen können gehören:

- Schwellungen
- Erhöhter Augeninnendruck
- Herabhängendes Augenlid

Diese Zustände sind in der Regel vorübergehend und bessern sich durch Medikamente und einen normalen Heilungsverlauf. Informieren Sie Ihren Augenarzt unverzüglich, wenn Sie Veränderungen bemerken, damit Ihr Genesung überwacht und gegebenenfalls behandelt werden kann.

■ Nachstar (Posterior Capsule Opacification, PCO)

Der Nachstar (Posterior Capsule Opacification, PCO) ist eine häufige Erscheinung, die nach einer Kataraktoperation auftreten kann. Er entsteht, wenn verbliebene Linsenzellen auf der dünnen Membran hinter der implantierten Linse wachsen und dadurch das Sehvermögen erneut trüben. Obwohl dies manchmal als „sekundäre Katarakt“ bezeichnet wird, handelt es sich nicht um einen neuen Katarakt.

PCO kann einfach durch einen schnellen und schmerzfreien Nd:YAG-Lasereingriff behandelt werden, der von Ihrem Augenarzt durchgeführt wird. Die Behandlung dauert in der Regel nur wenige Minuten, und die meisten Patienten bemerken innerhalb eines Tages eine Verbesserung ihres Sehvermögens. Wenn Ihr Augenarzt nach der Operation erneut verschommen wird, wenden Sie sich für weitere Beratung an Ihren Augenarzt.

Magnetresonanz-Kompatibilität

Die implantierte Intraokularlinse enthält keine metallischen Bestandteile und ist sicher, da kein Risiko einer Wechselwirkung mit dem Magnetresonanzfeld (MR-Feld) besteht. Die Intraokularlinse ist für Magnetresonanztomographie (MRT) bei Magnetfeldstärken von 1,5 Tesla und 3,0 Tesla geeignet.

Erwartete Lebensdauer und erforderliche Nachsorge

Die Intraokularlinse hält in der Regel ein Leben lang. Sollten Sie jedoch eine Verschlechterung Ihrer Sehqualität feststellen, wenden Sie sich bitte zur weiteren Untersuchung und Behandlung an Ihren Augenarzt. Ihr Augenarzt wird mit Ihnen die erforderlichen Nachsorgeintervalle entsprechend Ihrem Gesundheitszustand besprechen.

Meldung schwerwiegender Vorkommnisse

Jedes schwerwiegende Vorkommnis im Zusammenhang mit der Intraokularlinse sollte Ihrem Arzt (zunächst), dem örtlichen Vertreter oder EYEOU U.K. LIMITED gemeldet werden.

Über dieses Dokument

Ihr Augenarzt hat die Kataraktoperation durchgeführt und die Intraokularlinse (IOL) in Ihr Auge implantiert. Die Patienten-Implantatkarte und dieses Informationsblatt wurden Ihnen nach der Kataraktoperation ausgehändigt. Bitte führen Sie die Patienten-Implantatkarte stets mit sich, um im Notfall eine angemessene medizinische Versorgung zu erleichtern. Über den auf der Implantatkarte angegebenen Link erhalten Sie die neuesten Informationen zur Intraokularlinse.

		
8 Apex Business Centre, Boscombe Road, Dunstable, Bedfordshire, L15 4SB, Vereinigtes Königreich Tel.: +44 (0) 1582 477 002 Fax: +44 (0) 1582 607 009 E-Mail: info@eyeoel.co.uk Web: www.eyeoel.co.uk	Bd. Général Walsby, 53 1030 Bruxelles, Belgien Tel.: +32-2.732.59.54 Fax: +32-2.732.60.03 Email: mail@obelis.net Web: www.obelis.net	

Successivamente, utilizza un piccolo dispositivo simile a un aspiratore per rimuovere i frammenti di cataratta dall'occhio. A questo punto si crea lo spazio necessario per inserire la LIO nell'occhio e sostituire il cristallino naturale appena rimosso. Il medico inserirà la IOL attraverso la stessa piccola incisione. Al termine dell'intervento, l'oculista può applicare una medicazione protettiva o uno schermo protettivo sull'occhio.

Cosa aspettarsi dopo l'intervento di cataratta

Subito dopo l'intervento, dovete rimanere nell'area di recupero per un breve periodo. Il vostro oculista dovrebbe consegnarvi una scheda identificativa (generalmente chiamata scheda impianto) da conservare nel portafoglio. Questa scheda indica il tipo di impianto presente nel vostro occhio. Mostrate questa scheda a qualsiasi oculista che esami i vostri occhi dopo l'intervento. Presentate questa scheda a qualsiasi oculista che esaminerà i vostri occhi dopo l'intervento. Molti pazienti iniziano a vedere meglio entro 1 o 2 giorni. In alcuni casi la vista si stabilizza entro 10-14 giorni. Altri pazienti possono impiegare da 4 a 6 settimane per recuperare completamente dall'intervento. Il miglioramento della vista varia da persona a persona. Contattate immediatamente il vostro oculista se dopo l'intervento avvertite prurito, dolore, lampi di luce, "corpi mobili" (floaters), arrossamento, forte mal di testa, nausea/vomito, sensibilità alla luce o lacrimazione eccessiva.

Istruzioni per le cure post-operatorie

Potrete tornare a casa lo stesso giorno dell'intervento. Il vostro oculista vi prescriverà colliri antibiotici e farmaci per accelerare la guarigione e prevenire le infezioni. Assumete tutti i farmaci prescritti e applicate i colliri secondo le indicazioni del vostro oculista.

Durante la prima settimana dopo l'intervento, evitate di nuotare e di utilizzare vasche da bagno o idromassaggi per contribuire a prevenire le infezioni. Cercate inoltre di proteggere l'occhio da sporco, polvere e vento forte. Proteggetevi gli occhi il più possibile con occhiali da sole e dormite con la protezione oculare durante la notte. Evitate di strofinare l'occhio o di esercitare pressione su di esso. Vi verrà fissata una visita di controllo, generalmente il giorno successivo all'intervento. Il medico vi visiterà più volte dopo l'operazione in base alla velocità di guarigione. Potrebbe essere necessario un po' di tempo per abituarvi alla nuova IOL.

Parlate con il vostro oculista se avete domande o dubbi dopo l'intervento.

Effetti indesiderati, avvertenze e rischi residui

Fenomeni luminosi visivi

Dopo l'intervento di cataratta, alcuni pazienti possono notare abbagliamento o aloni, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Gli aloni appaiono come anelli luminosi attorno alle fonti di luce, mentre l'abbagliamento si manifesta come una luce intensa che può compromettere la visione notturna. Questi effetti possono essere più evidenti durante la guida notturna o osservando luci artificiali. In alcuni casi, questi effetti possono persistere anche dopo la guarigione completa.

Nella maggior parte dei casi, tali effetti migliorano entro poche settimane o mesi, man mano che il cervello si adatta alla lente intraoculare. Se persistono dopo la guarigione, consultate il vostro oculista. Seguite sempre le istruzioni del chirurgo e segnalate qualsiasi sintomo insolito.

Decentramento o potere diottrico non corretto della lente

In rari casi, la lente implantata può spostarsi leggermente dalla sua posizione all'interno dell'occhio, anche anni dopo l'intervento. Questo può causare disturbi visivi o abbagliamento, che generalmente possono essere corretti mediante una procedura chirurgica.

A volte il potere della lente potrebbe non corrispondere perfettamente all'occhio, il che può influenzare la visione. Questo può accadere se la lente non si posiziona esattamente come previsto o a causa di piccole differenze nei calcoli. Nella maggior parte dei casi, l'effetto è minimo. Se la differenza è maggiore, può generalmente essere corretta con occhiali, lenti a contatto, LASIK o un intervento chirurgico.

Informate il vostro medico se manifestate:

- forte dolore all'occhio
- arrossamento ricorrente dell'occhio
- aumento della pressione intraoculare
- notevole peggioramento della vista
- lampi di luce o un marcato aumento dei corpi mobili (floaters) nell'occhio

Queste sono complicanze rare che possono verificarsi poco dopo l'intervento chirurgico.

Infezioni e complicanze minori

Come per qualsiasi intervento chirurgico, esiste un piccolo rischio di infezione dopo l'intervento di cataratta, sebbene le complicanze gravi siano rare. Se si verifica un'infezione, di solito può essere trattata con colliri prescritti dal medico. Dovreste contattarle il vostro oculista se l'occhio si gonfia o se notate sintomi insorti.

Alcune complicanze minori possono includere:

- Gonfiore
- Aumento della pressione intraoculare
- Abbassamento della palpebra

Queste condizioni sono generalmente temporanee e migliorano con la terapia farmacologica e una corretta guarigione. Informate immediatamente il vostro oculista se notate qualsiasi cambiamento, in modo che il recupero possa essere monitorato e trattato se necessario.

Opacizzazione della capsula posteriore

L'opacizzazione della capsula posteriore (PCO) è una condizione comune che può verificarsi dopo l'intervento di cataratta. Si verifica quando alcune cellule residue del cristallino crescono sulla sottile membrana situata dietro la lente implantata, causando nuovamente un annebbiamento della vista. Sebbene venga talvolta chiamata "cataratta secondaria", non si tratta di una nuova cataratta.

La PCO può essere facilmente trattata mediante una procedura laser Nd-YAG rapida e indolore eseguita dal vostro oculista. Il trattamento richiede generalmente solo pochi minuti e la maggior parte dei pazienti nota un miglioramento della vista entro un giorno. Se la vostra vista torna ad essere sfocata dopo l'intervento, contattate il vostro oculista per ulteriori consigli.

Compatibilità con la Risonanza Magnetica

La IOL implantata non contiene componenti metallici ed è sicura, senza alcun potenziale di interazione con il campo di Risonanza Magnetica (RM). La IOL è sicura per l'esecuzione di esami di Risonanza Magnetica per Immagini (MRI) con intensità del campo magnetico di 1,5 Tesla e 3,0 Tesla.

Durata prevista e follow-up necessari

La IOL generalmente dura per tutta la vita del paziente. Tuttavia, qualora dovete riscontrare un peggioramento della qualità della vista, consultate il vostro oculista per ulteriori accertamenti e trattamenti. Il vostro oculista discuterà con voi la frequenza dei controlli necessari in base alle vostre condizioni cliniche.

Segnalazione di incidenti gravi

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione alla lente intraoculare deve essere segnalato al proprio medico (in prima istanza), al rappresentante locale o a EYEOU U.K. LIMITED.

Informazioni su questo documento

Il vostro oculista ha eseguito l'intervento di cataratta e ha impiantato la lente intraoculare (IOL) nel vostro occhio. La scheda impianto del paziente e questo foglio informativo vi sono stati consegnati dopo l'intervento di cataratta. Vi invitiamo a portare sempre con voi la scheda impianto del paziente per facilitare l'assistenza medica in caso di emergenza. Il collegamento riportato sulla scheda impianto vi fornirà gli aggiornamenti più recenti relativi alla IOL.